

Post 36-godzinny: badania, korzyści i ryzyko po 50-tce?



Hasła o „najlepszej medycynie”, autofagii włączanej o konkretnej godzinie i ochronie mięśni przez HGH łączą wyniki wielu różnych eksperymentów. W tym fact-checku sprawdzam, czy badania naprawdę dotyczyły 36 godzin, ludzi po 50-tce i trwałych efektów klinicznych. Wniosek jest mniej widowiskowy: post może organizować deficyt energii, ale nie zyskuje przez to właściwości leku.

Szybka odpowiedź

Post 36-godzinny nie jest cudowną terapią. Badania różnych protokołów postu pokazują zmiany ketonów i niektórych markerów metabolicznych, lecz nie dowodzą przewagi nad dobrze dobranym, trwałym ograniczeniem energii. Największe błędy to przypisywanie mu dokładnej godziny uruchomienia autofagii, ochrony mięśni przez HGH i zdolności zastępowania leczenia.

Kluczowe wnioski

- Badania postu naprzemiennego i ograniczonych okien żywieniowych nie są automatycznie badaniami jednorazowego postu 36-godzinnego.
- Ketony rosną wraz z czasem bez jedzenia, ale ich poziom zależy od wcześniejszej diety, aktywności i metabolizmu.
- Nie ustalono u ludzi uniwersalnego progu godzinowego dla autofagii.
- Hormon wzrostu może wzrastać, lecz bez aminokwasów synteza białek mięśniowych nie działa jak po posiłku i treningu.
- Przy lekach obniżających glukozę lub ciśnienie post może wymagać zmiany dawkowania wyłącznie przez lekarza.

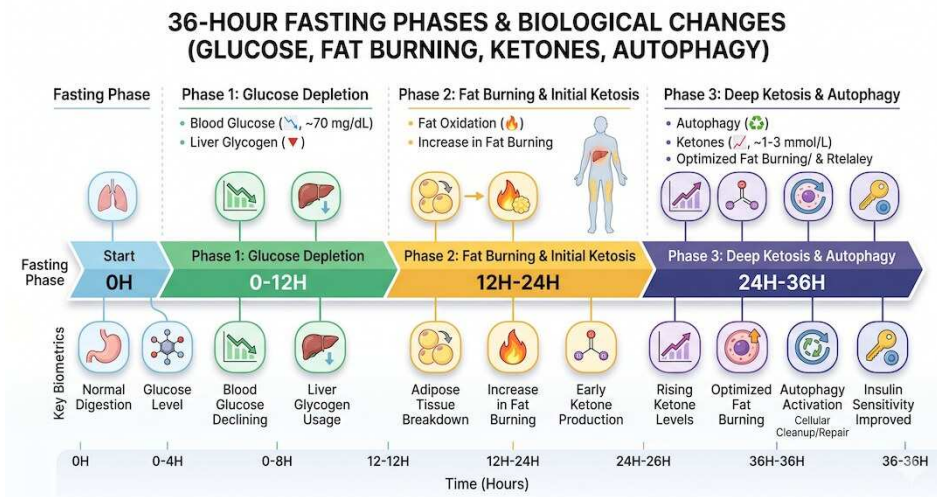
Popularne twierdzenia o poście 36-godzinnym a stan dowodów

Twierdzenie	Ocena	Dlaczego
„Resetuje insulinę”	Zbyt mocne	Niektóre protokoły postu poprawiają markery metaboliczne, ale wynik zależy także od deficytu energii i masy ciała
„Włącza autofagię po konkretnej godzinie”	Nieudowodnione	U ludzi nie ustalono uniwersalnego progu godzinowego
„Chroni mięśnie dzięki HGH”	Mylące	Wzrost hormonu wzrostu nie zastępuje aminokwasów ani treningu oporowego
„Jest najlepszą terapią metaboliczną”	Falsz	Nie porównano go jako zamiennika leków i standardowego leczenia

Dlaczego ten tekst nie powtarza osi czasu postu?

Drugi artykuł FitPo50 opisuje fizjologię kolejnych godzin bez jedzenia. Tutaj pytanie jest inne: czy internetowe obietnice wynikają z badań przeprowadzonych dokładnie na 36-godzinny poście. To rozróżnienie jest ważne, bo wynik postu naprzemiennego, okna żywieniowego 8–10 godzin albo wielodniowego głodzenia nie może być automatycznie przypisany jednej dobie i nocy bez posiłku.

W badaniach pod wspólnym hasłem „intermittent fasting” mieszczą się różne interwencje. Uczestnicy mogą jeść tylko o określonych porach, pościć co drugi dzień, ograniczać energię w dwa dni tygodnia albo nie jeść przez 24–36 godzin. Różnią się także deficytem kalorii, długością obserwacji, wiekiem i chorobami uczestników. Dlatego uczciwy wniosek musi nazywać konkretny protokół.



Najpierw sprawdź protokół badania, potem wynik. Sama etykieta „post” nie wystarcza.

Czy 36 godzin bez jedzenia daje przewagę nad zwykłym deficytem?

Badania przerywanego postu często pokazują spadek masy ciała i poprawę części markerów metabolicznych, ale w bezpośrednich porównaniach przewaga nad stałym ograniczeniem energii zwykle nie jest wyraźna. Dla wielu osób mechanizmem korzyści jest po prostu mniejsza tygodniowa podaż kalorii. To nie umniejsza metodzie, lecz zmienia obietnicę: liczy się wykonalność, a nie wyjątkowa „magia” 36 godzin.



Długi post jest jedną ze strategii ograniczania energii; przewagę trzeba oceniać względem prostszego, trwałego deficytu.

Jeżeli po poście pojawia się nadrabianie jedzenia, gorszy sen albo rezygnacja z treningu, te koszty mogą zniwelować korzyść. Z kolei osoba, której łatwiej nie jeść przez dłuższy okres niż codziennie liczyć porcje, może uznać taki schemat za prostszy. O wyniku decyduje wzorec utrzymany przez miesiąc, nie najwyższy poziom ketonów jednego dnia.

Przy insulinooporności najpierw trzeba oddzielić krótkotrwały spadek insuliny podczas niejedzenia od trwałej poprawy zdrowia. HOMA-IR jest obliczanym markerem, a jego zmiana nie oznacza „resetu” receptorów. Jeśli chcesz zrozumieć wyniki glukozy i lipidów, zacznij od poradnika [o badaniach krwi po 50-tce](#), a leczenia nie zmieniaj bez lekarza.

Czy autofagia uruchamia się dokładnie po 24 godzinach?

Nie znamy takiego uniwersalnego progu u człowieka. Autofagia działa stale, a jej natężenie zmienia się zależnie od tkanki, dostępności energii, aktywności i wielu sygnałów komórkowych. Badanie pokazujące zmianę wybranego markera po określonym protokole nie tworzy zegara, który o konkretnej godzinie włącza „sprzątanie komórek” w całym organizmie.



Autofagia zachodzi dynamicznie i zależy od tkanki oraz warunków; badanie komórek nie wyznacza jednej godziny dla całego człowieka.

Eksploracyjne badanie żywienia ograniczonego czasowo opublikowane w 2025 roku dostarczyło interesujących danych o strumieniu autofagicznym u ludzi, ale dotyczyło powtarzanego protokołu i wymaga replikacji. Nie sprawdzało, czy jednorazowy post 36-godzinny odmładza tkanki, usuwa komórki nowotworowe albo wydłuża życie. Takie dopowiedzenia są marketingiem, nie wynikiem publikacji.

Wniosek dla czytelnika

Jeżeli autor podaje dokładną godzinę „włączenia autofagii”, powinien wskazać badanie na ludziach, badaną tkankę, metodę pomiaru i protokół. Bez tych czterech elementów liczba jest pozorną precyzją.

Czy wzrost HGH chroni mięśnie po 50-tce?

Podczas postu hormon wzrostu może wzrosnąć, lecz nie zamienia głodzenia w stan anaboliczny. Synteza białek mięśniowych potrzebuje aminokwasów, energii i bodźca mechanicznego. HGH pomaga regulować wykorzystanie paliw, ale nie jest zastępstwem posiłku białkowego ani treningu. Szczególnie po 50-tce warto oceniać cały tydzień: białko, siłę, sen i całkowitą podaż energii.

Największe ryzyko nie wynika z jednej pominiętej kolacji, lecz z regularnego protokołu, który utrudnia pokrycie zapotrzebowania. Osoba szczupła, z małym apetytem, sarkopenią lub intensywnie trenująca może mieć inny bilans niż osoba z otyłością i wysoką podażą energii. Plan ochrony mięśni znajdziesz w [Centrum Białka po 50-tce](#) i w materiale o [treningu siłowym po 50-tce](#).



Wzrost HGH podczas postu nie zastępuje aminokwasów i treningu oporowego.

Kto nie powinien testować 36-godzinnego postu samodzielnie?

Bez konsultacji nie powinny zaczynać osoby przyjmujące insulinę lub leki mogące powodować hipoglikemię, z zaburzeniami odżywiania, niedowagą, aktywną chorobą nerek lub wątroby, w ciąży i podczas karmienia. Ostrożność jest potrzebna również przy lekach na ciśnienie, diuretykach, omdleniach, dnie moczanowej i przyjmowaniu preparatów wymagających posiłku.



Leki obniżające glukozę i niektóre choroby zwiększają ryzyko, dlatego długiego postu nie należy wtedy testować samodzielnie.

Nie traktuj silnych zawrotów głowy, splątania, omdlenia, kołatania serca lub objawów hipoglikemii jako „detoksu”. Nie uzupełniaj potasu na własną rękę: przy chorobie nerek oraz części leków nadmiar może być groźny. Przerwanie postu nie jest porażką, tylko właściwą reakcją na sygnał bezpieczeństwa.

Jeśli interesuje Cię łagodniejszy sposób uporządkowania pór posiłków, porównaj go z poradnikiem o [poście przerywanym po 50-tce](#). Krótsze okno nocne bywa łatwiejsze do pogodzenia z lekami, białkiem i życiem społecznym, choć także nie jest obowiązkowe.

Jak podjąć decyzję bez ulegania hype'owi?

Zacznij od celu, którego wynik da się sprawdzić: średnia masa ciała, obwód pasa, domowe ciśnienie, glukoza lub tolerancja planu. Następnie zapisz leki, godziny ich przyjmowania, wcześniejsze omdlenia i sposób pokrycia białka w dniach jedzenia. Jeśli nie potrafisz nazwać mierzalnego celu, post prawdopodobnie jest eksperymentem inspirowanym reklamą, nie rozwiązaniem problemu.



Rozsądna decyzja uwzględnia jakość dowodów, zdrowie, leki i możliwość utrzymania planu bez internetowej presji.

- Nie zmieniaj dawek leków po przeczytaniu artykułu.
- Nie zaczynaj od 36 godzin, jeśli zwykła nocna przerwa już wywołuje objawy.
- Nie łącz pierwszej próby z ciężkim treningiem, alkoholem ani sauną.
- Oceń efekt po tygodniach nawyków, nie po jednym porannym pomiarze.
- Zakończ próbę, jeśli pogarsza sen, kontrolę jedzenia albo regularność treningu.

Najmocniejszy werdykt jest zarazem najmniej widowiskowy: post 36-godzinny może być dla części osób metodą organizacji deficytu energii, ale nie jest najlepszą medycyną, automatycznym aktywatorem autofagii ani ochroną mięśni. Widoczny efekt zdrowotny musi przetrwać dłużej niż sam okres niejedzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Czy post 36-godzinny leczy insulinooporność?

Nie można tak powiedzieć. Podczas postu insulina zwykle spada, a część protokołów poprawia markery metaboliczne, ale wynik zależy też od podaży energii, masy ciała i aktywności. Post nie zastępuje diagnostyki ani leczenia.

Po ilu godzinach zaczyna się autofagia?

U ludzi nie ustalono uniwersalnej godziny. Autofagia zachodzi stale i różni się między tkankami. Badania konkretnych markerów nie pozwalają stworzyć zegara 18, 24 lub 36 godzin dla całego organizmu.

Czy HGH zapobiega utracie mięśni podczas postu?

Nie daje takiej gwarancji. Hormon wzrostu może rosnąć, lecz synteza białek mięśniowych nadal wymaga aminokwasów, energii i treningu. Znaczenie ma cały tygodniowy bilans jedzenia i obciążeń.

Czy elektrolity czynią długi post bezpiecznym?

Nie. Mogą nie rozwiązać problemu leków, hipoglikemii, omdleń lub chorób nerek. Potasu nie należy suplementować samodzielnie, zwłaszcza przy chorobie nerek i lekach wpływających na jego stężenie.

Dawkę białka, najlepsze źródła, odżywki i strategie ochrony mięśni zebraliśmy w [Centrum Białka po 50-tce](#).

Źródła

1. [Stekovic et al. – Alternate Day Fasting Improves Physiological and Molecular Markers of Aging in Healthy Non-obese Humans \(Cell Metabolism, 2019\)](#)
2. [Bensalem et al. – Intermittent time-restricted eating increases autophagic flux in humans: exploratory analysis \(Journal of Physiology, maj 2025\)](#)
3. [Borer et al. – Twice-Weekly 36-Hour Intermittent Fasting Quadruples Beta-Hydroxybutyrate and Maintains Weight Loss \(PMC, 2024\)](#)
4. [Horne et al. – Insulin Resistance Reduction, Intermittent Fasting and Human Growth Hormone \(NPJ Metabolic Health and Disease, 2024\)](#)
5. [Horne et al. – Weight Loss-Independent Changes in HGH During Water-Only Fasting \(Frontiers in Endocrinology, 2025\)](#)
6. [Naegel et al. – Impact of Long-Term Fasting on Skeletal Muscle Structure, Metabolism and Function \(Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle, 2025\)](#)
7. [Endocrine Reviews 2025 – Critical Assessment of Fasting to Promote Metabolic Health and Longevity \(Oxford Academic\)](#)
8. [PMC 2025 – Role of Intermittent Fasting in Activation of Autophagy in Context of Cancer Diseases](#)
9. [Rolland et al. – Training State and Skeletal Muscle Autophagy in Response to 36h Fasting \(PubMed, 2018\)](#)
10. [Moser et al. – Impact of a Single 36 Hours Prolonged Fasting Period in Adults With Type 1 Diabetes \(Frontiers in Endocrinology, 2021\)](#)

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji lekarskiej, diagnozy ani leczenia.